

指导语及评分

F9. 汉密尔顿抑郁量表（HAMD）

由 Hamilton 于 1960 年编制，是临床上评定抑郁状态时应用得最为普遍的量表。该量表有 17 项、21 项和 24 项等 3 种版本，目前这里使用 17 项版本，由经过培训的两名评定者对患者进行 HAMD 联合检查，独立评分。需要强调：评定者必须通过交谈和观察两种方式进行评价，尤其在受试者不配合提供虚假信息 and 回答的时候，评价应该更倾向于专业评定者的观察。

指导语：询问患者本人，对患者近 2 周的表现进行评价，由医生在每项提问后选择填写。最先问诊的条目是睡眠情况，可以减少受试者的警戒心。

评价标准：

- 1) 入睡困难，近 2 周无症状=0 分，有时上床半个小时仍不能入睡=1 分，每晚都有入睡困难=2 分；
- 2) 睡眠不深：近 2 周无症状=0 分，睡眠浅、多梦=1 分，不包括起夜上厕所，午夜前醒来=2 分；
- 3) 早醒：近 2 周无症状=0 分，比平时早一个小时前醒来，但能接着入睡=1 分，早醒后无法入睡=2 分；
- 4) 忧郁情绪：近 2 周无症状=0 分，只有问道才说=1 分，在访谈中自发描述=2 分；不用言语也能从表情、姿势和声音中流露=3 分，受试者的语言和表情声音等完全体现=4 分
- 5) 有罪恶感：近 2 周无症状=0 分，常责备自己、感到连累他人=1 分，反复思考既往过失=2 分，认为目前的疾病是对自己的惩罚或有罪恶妄想=3 分，罪恶妄想还伴有指责或威胁性幻想=4 分
- 6) 自杀：近 2 周无症状=0 分，觉得活着没意思=1 分，想与死亡有关的事情=2 分，有自杀的念头=3 分，有自杀的行动=4 分；
- 7) 工作和兴趣：近 2 周无症状=0 分，只有问道才说=1 分，在访谈中自发描述失去兴趣=2 分；活动时间及效率减少=3 分，没有帮助就不进行任何活动=4 分；
- 8) 通过对受试者的观察而进行评分：
 - A) 阻滞（观察受试者对问诊的反应快慢）
能够回答但较正常人稍慢=1 分，回答和反应明显比正常人慢=2 分，交谈困难=3 分，完全不能回答问题=4 分；
 - B) 激越（受试者是否表现出紧张、不安，有没有搓手、咬嘴唇、站起等动作）
有时候心神不定=1 分，小动作多=2 分，不能静坐曾在访谈过程中站起=3 分，一直不停的做小动作，走神儿=4 分；
- 9) 焦虑：A) 精神性：近 2 周心情总是担心、担忧、紧张不安；B) 躯体性症状：近 2 周包括口干、腹胀、腹泻、打嗝、心绞痛、心悸、头痛、过度换气和叹息，以及尿频和出汗等；
- 10) 胃肠道症状：食欲减退：近 2 周不需他人鼓励自己进食=1 分，需他人催促或用药=2 分；
- 11) 全身症状：近 2 周四肢、背部、头颈部、肌肉的沉重感、疲乏或疼痛；因此去就诊=2 分；
- 12) 性症状：近 2 周夫妻关系是否和谐，需要用药物帮助=2 分；
- 13) 疑病：近 2 周常常因为身体轻微不舒服就去医院就诊=3 分；
- 14) 体重减轻：近 2 周不足 1 斤/周=0 分，下降 1-2 斤/周=1 分，下降 2 斤以上/周=2 分；

15) 自知力: 近 2 周能正确认识自身状况或者承认有病且归因正确=0 分, 承认有病但是归因不正确=1 分, 否认有病=2 分。

评分: 大部分项目用 0~4 分的 5 级评定: 0=无, 1=轻度, 2=中度, 3=重度, 4=极重度; 少数项目采用 0~2 分的 3 级评分法, 即 0=无, 1=轻中度, 2=重度。

参考值: <7 分为正常; ≥7 分可能有抑郁; ≥17 分肯定有抑郁; ≥24 分严重抑郁。

F10. 汉密尔顿焦虑量表 (HAMA)

指导语: 询问患者本人, 对患者近 1 周的表现进行评价, 由医生在每项提问后选择填写。

评分: 所有项目用 0~4 分 5 级评定: 0=无, 1=轻度, 2=中度, 3=重度, 4=极重度。

方式: 一般采用交谈与观察的方式, 评定当时或入组前 1 周的情况;

问诊要点 (层层递进):

- 1) 近 1 周是否有该症状呢? (答否=0 分)
- 2) 答是的话, 是否明显呢? (答否=1 分)
- 3) 答是的话, 是否影响生活呢? (答否=2 分)
- 4) 答是的话, 有前去就诊和进行处理吗? (答是=3 分)
- 5) 答是的话, 处理后仍觉得严重影响生活吗? (答是=4 分)

参考值: 总分 ≥29 分, 可能为严重焦虑; ≥21 分, 肯定有明显焦虑; ≥14 分, 肯定有焦虑; ≥7 分, 可能有焦虑; 如小于 7 分, 没有焦虑。

需要强调: 评定者必须通过交谈和观察两种方式进行评价, 尤其在受试者不配合提供虚假信息的时候, 评价应该更倾向于评定者的观察。

H1. 爱丁堡利手量表

计算: 结果=两侧差值 (右-左) ×5

结果判断: <-40 为左利手; -40~+40 之间为双利手; >+40 为右利手。

H2. MMSE

1975 年 Folstein 创立了简易精神状态检查法 并开始广泛应用, 是最常用的认知及智能检查量表, 1988 年李格, 沈渔邨教授翻译为中文版本, 我们现在应用的是在张明园教授的版本上改编而成的。

总共 30 个条目, 共 30 分。

1. 定向: 日期和星期差一天即为错误。
2. 地点: 为测试时所在地, 而不是平时所熟悉的地方。
3. 记忆: 仔细说清楚, 每样东西用一秒钟, 如果受试者不能完全说出, 可以重复, 最多 6 遍, 但以第一遍为得分依据。不要解释词语。例如: 受试者问: shumu 是人道树的树木还是数目字的数目, 可以回答都行, 而不是告知“是人道树的树木”, 后者为线索记忆。延迟记忆: 刚才我让您记了三种东西, 现在请您回忆一下是哪三种东西。
4. 注意和计算: 每一个正确答案 1 分, 如果上一个错了, 如 100-7=90, 下一个对, 如 90-7=83, 第二个仍给分)。
5. 三步指令: 细节要求: 口令没有间断, 不理睬打岔; 用 20cmX30cm 白纸; 如果受试者说“没有听清楚”, 可以说“只要做你听到的部分”; 主试者不要做递纸和要纸的动作, 如果折纸超过 1 次, 对折部分就给 0 分。
6. 阅读理解: 念对并有闭眼睛的动作才给分 1 分。
7. 书写: 遇文盲老人, 不会写字的不给分。句子应有主语谓语, 必须有意义, 能被人理

解。

8.视空间能力：角不锐和边不直可忽略不计。两图形必须交叉，必须有 10 个角，交叉后的图需成四边形。

节点分数：

17 分（文盲），20 分（1-6 年），24 分（>6 年）

H3. **AVLT-H:**

指导语：

N1：“我要给你读 12 个词，请您仔细听，我都读完后，请您根据记忆尽可能多地说出这些词语，可以不考虑您说的顺序，现在开始，回忆得越多越好。”

对于受试者回答重复或错误，不给予反馈。

接着 N2：“现在我再读一遍同样的词，我都读完请您回忆，回忆包括刚才说过的词，不用管您说的次序，说得越多越好。”

接着 N3：“现在我读最后一遍同样的词，我都读完请您回忆，回忆包括刚才说过的词语，不用管您说的次序，说得越多越好”

N4：5 分钟后——“请您回忆一下我刚才读过的 12 个词语”

N5：20 分钟——“请您回忆一下我刚才读过的 12 个词语”

N6：“我刚才读的词可以分为三类，你知道花朵类的有哪些吗？职业类的有哪些？服饰类的又有哪些呢？”

N7：“我现在要读 24 个词语，12 个是我刚才读过的，12 个是新加入的，我每读完一个词语后请您告诉我这个词是我刚才读过的吗？”

评分：每对一个记 1 分。即刻回忆、延迟回忆每次检查结果满分 12 分，每次能够正确回忆的个数，就是该项目的得分。再认的话总分=24 分-错误数。异常值是指小于等于节点。

-1.0SD

50-59 岁：5 60-69 岁：4 70-79：3

再认（N7）节点

-1.0SD

50-59 岁：20 60-69 岁：19 70-79：18

H4. **词语流畅性测试:**

指导语：请您在 1 分钟的时间内尽可能快的说出您知道的动物的名字，说的越多越好。准备好了吗？开始”异常值是指小于等于节点。

节点： 初中 高中 大学

-1.0SD 12 个 13 个 14 个

H5. **Boston 命名测验:**

指导语：“我现在给你看一些图片，请你告诉我这些图片是什么”。

如果被测试者未能讲出答案，便给予提示：例如说“这是（植物），还有别的名称没有？”。若仍不能回答，则顺序讲出三个答案让被测试者选择。谨记要把被测试者的每一个答案如实记录，不论正确与否（答对=√；答错=X）

20s 内正确命名该图形则给分。只有当受试者明显误解某幅图片时，才被告知图片像其他东西提供括号里的语义线索。无论是自发的还是语义提示，每次提示后仍回答错误给予语音提示，例如：受试者将“蘑菇”回答为“雨伞”，就提示她是“吃的东西”，并且再给 20s 命名该图片。如果受试者在 20s 内正确命名该条目，核对线索提示后的正确数目。如果给予线索提示，患者无法在 20s 内正确命名该图片，就给予选择提示”

节点： 初中 高中 大学
-1.0SD 19 个 21 个 22 个

小于等于节点为异常。

H6. 形状连线测验（Shape trailing test, STT）

STT 属于传统连线测验的一个变异版本，是将数字包含在正方形和圆形两种图形中，STT-B 部分，按顺序连接数字时两种图形要交替进行。这种基于不同形状的连线测验，我们称为 STT。

H6.1 STT-A 部分

练习题：“这里有些数字，当我说数字‘开始’时，请你把他们按顺序连起来。从 1（指着 1），到 2（指着 2），再到 3（指着 3）……如此类推，直至完成为止。注意：笔尖切勿离开纸张。如果你做错了，我会指出，那么你退回来，从前一个正确的数字再开始。你所画的线必须穿过这个图形。现在请你把笔放到这里（指着起点），当我说‘开始’时，你尽快把数字按顺序连起来，直到这个终点为止（指着终点）。准备好了吗？开始”（计时）。

测验题：“这里有更多数字，跟刚才一样，请你按顺序把他们连起来。要尽快做，笔尖切勿离开纸张，所画线条亦必须穿过图形。从这里开始（指着起点），直到这里为止（指着终点）。准备好了吗？开始”（计时）。

评分（中学及以上）：

记录总耗时数：练习题与测试题。异常值是指大于等于节点。

-1.0SD

年龄分组 50-59 岁 60-69 岁 70-79 岁

70s 80s 100s

H6.2 STT-B 部分：

练习题：“这里的数字包含在两种图形里，现在要你按照顺序把数字连起来，而两种图形要梅花间竹的排列。例如正方形 1（指向正方形 1）到圆形 2（指向圆形 2）”，再到正方形 3（指向正方形 3）……如此类推，直到终点。注意：形状梅花间竹的交替排列。如果你做错，我会指出，那你便要从前面那个正确的图形开始，你所画的图形必须穿过这个图形，现在你把笔放在这儿，当我说开始时，你尽快把数字按顺序连起来，直到这个终点，准备好了吗？开始”（计时）。

测试题：“这里有更多数字，跟刚才一样，请你按照顺序把它们连起来，而图形要梅花间竹的排列。要尽快做，笔尖切勿离开纸张，所画线条亦必须穿过图形。从这里开始（指向起点）到这里结束（指向终点）。准备好了吗？开始”（计时）。

注意：受试者连接错误，应该即刻告诉他，所以，您要密切观察受试者的表现，尽可能快

的发现受试者的错误；如果受试者手遮住答案，下一个数字找不到了，你可以等大致 10 秒，还是找不到，可以告诉受试者数字在哪里，这个指点算是提示，不作为错误分，但是要记录提示次数。

评分（中学及以上）：

记录总耗时数：练习题与测试题。异常值是指大于等于节点。

-1.0SD

年龄分组 50-59 岁 60-69 岁 70-79 岁

 180s 200s 240s

H7. 老年抑郁量表（GDS）

GDS 概述：由于老年人躯体主诉多，而其中许多躯体主诉在老年阶段属于正常范围，却被误诊为抑郁症。1982 年由美国心理学家 Brink 等人创制老年抑郁量表（the Geriatric Depression Scale，简称 GDS）作为专用于老年人的抑郁筛查表，从而更敏感地检查老年抑郁患者所特有的躯体症状。

GDS 内容：该量表共有 15 个条目，代表了老年抑郁的核心，包含以下症状：情绪低落、活动减少，对过去、现在与将来的消极评价。

GDS 评定：每个条目都是一句问话，指示语是“选择最切合你最近一周来的感受的答案”，要求受试者回答“是”或“否”；15 个条目中有 5 条用反序计分（回答“否”表示抑郁存在），10 条用正序计分（回答“是”表示抑郁存在）。

GDS 评分标准：15 个条目中每项表示抑郁的回答得 1 分，得分在 0-15 分之间，界值如下：

0-4 分为正常；5-8 分轻度抑郁；9-11 中度抑郁；12-15 分为重度抑郁

GDS 评估注意事项：本量表可用口述或书面两种方式检查。用于书面方式，须在每个问题后印有是/否字样，让受试者圈出比较贴切的回答；若口头提问，检查者可能要重复某些问题已获得确切的“是”或“否”的回答。GDS 为老年人的抑郁筛查表，阳性者需要进一步检查确诊

H8. 记忆与执行功能量表（MES）

第一题：读出句子，不要给受试者看。

注意：

- （1）要一口气读完，不要在中途回答受试者提问。
- （2）第三次回忆结束时，告知受试“请把它记住，等会儿要请你回忆”

(3) 假如受试第一次和第二次全部回忆正确，仍需要学习第三次。

评分方法：方括号内为要点，方括号外为非要点。共 10 个要点，每个要点完全正确得 1 分，部分正确，如“58 号说成 38 号”也不得分，“灰色的小狗”说成“小灰狗”也不得分。只要说出要点，非要点（如：“有”“住在”）不管是否回答不计分。要点的次序颠倒（如说成“李小明的 2 只小狗是灰色的”）不扣分。

第二题：正确举例一个 1 分，满分 10 分。

第三题：扣指。评分方法：满分 10 分。圈出错误数字，每个错误扣除 1 分，直到 0 分。记录耗时数。注意：

- (1) 受试者理解了才能开始做，正式开始后以匀速进行。
- (2) 避免给受试应该敲还是不该敲的暗示。
- (3) 受试者扣指以敲到桌面为准，到半路停止的不计。
- (4) 为了避免敲伤受试者手指，敲桌子也可以是拍桌子，或手握铅笔敲桌子。

第四题：短延迟回忆：评分方法同第一题

第五题：评分方法：都是连续动作，要求动作次序和手势形态同时正确（即时间和空间两方面同时正确）。只对正确的动作评分，2 分=第一次动作正确；1 分=第 2 次动作正确；0 分=两次动作都不正确。

动作（以下为主试者所做动作要领，不要读给受试者听）

- (1) 拇指连续接触示指、中指、环指、小指的指尖（连续组成 4 个 O 型）
- (2) 拇指夹在屈曲的示指和中指间，其他手指屈曲-剪刀状（示指和中指做剪刀的动作，其他手指屈曲）
- (3) 手像试管一样卷起来放在眼前（望远镜状）-同侧耳朵上（倾听状）-嘴巴前面（喝水状）
- (4) 画十字（依次触碰前额、前胸、对侧和同侧的肩膀）
- (5) 攥拳头-掌缘往下砍-手指并拢平放在桌面、手背朝下

6. 评分方法同第三题（错一个扣一分，扣完为止）。

7. 评分方法同第一题。

节点：界值：所有教育程度 75 分。

H9. 功能活动问卷（FAQ）

FAQ 概述：此问卷由 Pfeffer 于 1982 年编制。主要是作为一种筛查工具用于测定老年人独

立生活的能力。量表是由患者与知情者同时做出的最能合适地反应老年人活动能力的评分。目的是为了更好发现和评价那些功能障碍不太严重的老年患者，即早期或者轻度痴呆患者。

FAQ 内容：该量表共有 10 个条目，包括使用通讯工具、整理物品、自行购物、技巧性活动、使用电器、准备饭菜、了解新鲜事物、注意和理解、记得约定、独自在外出。

FAQ 评定：由知情者完成，评定指标为项目总分。

FAQ 评分标准：评分采用 0~3 的四级评分法。0=没有任何困难，能独立完成，不需他人帮助；1=有些困难，需要他人指导或监督；2=需要帮助才能完成，部分依赖；3=本人无法完成，或完全由他人代替完成；NA=该项目不适合，或老人从来不做。

FAQ 评估注意事项：评定时，每一道问题只能选择一个评定，不要重复评定。也不要遗漏。作出最合适地反映老人活动能力的评分。

FAQ 应用：为 Jak & Bondi 的 MCI 神经心理学诊断标准用来诊断 MCI 的独立诊断指标；界值：**MCI: ≥ 9** ；**SCD: 参考范围 6-8**。

H10. 神经精神量表（NPI）

指导语：患者出现智能损害或记忆力障碍后，**近一个月**是否有以下行为的改变，如果有，请按照严重程度进行分级。

评分：症状有无 1=有；0=无

频率：（1~4）1分=偶尔，少于每周1次；2分=经常，大约每周1次；3分=频繁，每周几次但少于每天1次；4分=十分频繁，每天一次或更多或者持续。

严重程度：（1~3）1分=轻度，可以觉察但不明显；2分=中度，明显但不十分突出；3分=重度，非常突出的变化。

该项症状引起照料者的苦恼程度（0~5）0分=不苦恼；1分=极轻度的苦恼，照料者无需采取措施应对；2分=轻度苦恼，照料者很容易应对；3分=中度苦恼，照料者难以自行应对；4分=重度苦恼，照料者难以应对；5分=极度苦恼，照料者无法应对。

H11. 日常认知量表（Ecog）

Ecog 概述：由加州大学戴维斯医学院神经科 Tomaszewski Farias S 等人于 2008 年编制。用于检测日常功能活动。

Ecog 内容：该量表共有 12 个条目，涵盖 6 个认知域：日常记忆、日常语言、日常视空

间、日常计划、日常组织和日常注意分割。

Ecog 评定：由知情者完成。所有项目的得分相加得到一个总分，然后除以完成的项目数，总体得分范围 1-4。

Ecog 评分标准：将被试认知功能改变程度分为 4 个等级。1=比 10 年前的状况要好，或跟 10 年前差不多；2=好像差一点，或者偶尔差一点；3=肯定差一点；4=差多了，或明显减退
NA=不知道，无法判断，或者患者从不做该事。

Ecog 应用：敏感性 80%，特异性 81%，最佳划界分 2.30；识别痴呆与正常人群，特异性 95%，最佳划界分 2.83；识别 MCI 和正常人，特异性 62%，最佳划界分 1.54。

H12. 匹茨堡睡眠质量指数量表（PSQI）

PSQI 用于评定被试最近 1 个月的睡眠质量。由 19 个自评和 5 个他评条目构成，其中第 19 个自评条目和 5 个他评条目不参与计分，18 个条目组成 7 个睡眠因子成份，每个成份按 0~3 等级计分，累积各成份得分为 PSQI 总分，总分范围为 0~21，得分越高，表示睡眠质量越差。被试者完成试问需要 5~10 分钟。

指导语：下面的一些问题是关于您最近一个月的睡眠状况，请填写或选择出最符合您实际情况的答案。

各成份含意及计分方法如下：

A 睡眠质量

根据条目 6 计分，很好计 0 分，较好计 1 分，较差计 2 分，很差计 3 分。

B 入睡时间

1. 条目 2 的计分为≤15 分计 0 分，16~30 分计 1 分，31~60 计 2 分，≥60 分计 3 分。

2. 条目 5a 的计分为无，计 0 分，<1 次/周计 1 分，1~2 次/周计 2 分，≥3 次/周计 3 分。

3. 累加条目 2 和 5a 的计分，若累加分为 0 计 0 分，1~2 计 1 分，3~4 计 2 分，5~6 计 3 分

C 睡眠时间

根据条目 4 的应答计分，>7 小时计 0 分，6~7 计 1 分，5~6 计 2 分，<5 小时计 3 分。

D 睡眠效率

1. 床上时间 = 条目 3（起床时间）- 条目 1（上床时间）

2. 睡眠效率 = 条目 4（睡眠时间）/ 床上时间 × 100%

3. 成分 D 计分为，若睡眠效率 > 85%，则成分 D=0 分，若睡眠效率为 75~84%，则成分 D=1 分，若睡眠效率为 65~74%，则成分 D=2 分，若睡眠效率为 < 65%，则成分 D=3 分。

E 睡眠障碍

根据条目 5b 至 5j 的计分为，无=0 分，<1 次/周=1 分，1~2 次/周=2 分，≥3 次/周=3 分。累加条目 5b 至 5j 的计分，若累加分为 0，则成分 E=0 分，若累加分为 1~9，则成分 E =1 分，若累加分为 10~18，则成分 E =2 分，若累加分为 19~27，则成分 E =3 分。

F 催眠药物

根据条目 7 的应答计分，无计 0 分，<1 次/周计 1 分，1~2 次/周计 2 分，≥3 次/周计 3 分。

G 日间功能障碍：

1. 根据条目 8 的应答计分，无计 0 分，<1 次/周计 1 分，1~2 次/周计 2 分，≥3 次/周计 3 分。

2. 根据条目 9 的应答计分，没有计 0 分，偶尔有计 1 分，有时有计 2 分，经常有计 3 分。

3. 累加条目 8 和 9 的得分，若累加分为 0 则成分 G 计 0 分，1~2 计 1 分，3~4 计 2 分，5~6 计 3 分

PSQI 总分 = 成分 A + 成分 B + 成分 C + 成分 D + 成分 E + 成分 F + 成分 G

评价等级：

0-5 分 睡眠质量很好

6-10 分 睡眠质量还行

11-15 分 睡眠质量一般

16-21 分 睡眠质量很差

H13. 快速眼动睡眠期行为障碍量表（RBDSQ）

答“是”得一分，答“否”不得分，最好由患者及和被试睡同一个房间或同一张床的知情者同时完成。普通人群中诊断 RBD 的最佳阈值是 5，在帕金森病患者诊断 RBD 的是 6。

H14. 爱泼沃斯嗜睡量表（Epworth Sleepiness Scale, ESS）

指导语：在下列情况下你打瞌睡（不仅仅是感到疲倦）的可能如何？这是指你最近几月的通常生活情况；假如你最近没有做过其中的某些事情，请试着填上它们可能会给你带来多大的影响。

评分标准是按照所选择的 0、1、2、3 为相应分值，分值越高，提示瞌睡倾向越明显。>6 分提示有日间瞌睡倾向，>11 分提示过度日间瞌睡，>16 分提示有危险性的日间瞌睡。

H15. 蒙特利尔认知评估量表基础量表中文版（MoCA-B）

概述：蒙特利尔认知评估（Montreal cognitive assessment, MoCA）量表是由 Nasreddine 等

2004 年编制的用于快速筛查轻度认知功能损害（MCI）的评定工具。目前，中文版的 MoCA 在国内版本较多。最早翻译、验证并推广的版本是北京解放军总医院解恒革教授的译本。然而，MoCA 在发展中国家应用有一个普遍存在的问题，就是文盲与低教育老人的适用性。为了适于低教育老人的认知评估，Nasreddine 等于 2014 年 6 月发表了新版本，称为蒙特利尔认知评估基础量表（MoCA-B）。复旦大学附属华山医院神经内科教授郭起浩老师于 2015 年 7 月与 Nasreddine 取得联系，签署了中文版翻译协议，经过大量讨论与回译，最终确定了中文版本。

内容：

右上角记录开始时间

执行功能（连线）：请您按照从数字到点并逐渐升高的顺序画一条连线。从这里开始（指向数字 1），从数字 1 连向一个点（指向含有一个点的正方形），再连向数字 2（指向数字 2）之后再连向两个点（指向含有两个点的正方形），并一直连下去，到这里结束（含有 6 个点的正方形）

评分：当受试者完全按照顺序进行连线给 1 分，当受试者未按照顺序连线并出现任何错误，给 0 分。

即刻回忆：这是一个记忆力测试。下面我会给您念 5 个词，您要注意听，一定要记住。当我读完后，把您记住的词告诉我。回答时想到哪个就说哪个，不必按照我读的顺序。1 秒钟一个，把受试者回答正确的词在第一试的空栏中标出。当受试者回答出所有词，或是再也回忆不起来时，把 5 个词再读 1 遍，并向受试者说明，“我把这些词再读一遍，努力记住它们并把记住的词告诉我，包括您在第一次已经说过的词”在第二空栏中标出。“请您记住这些词，我之后还会让您回忆这些词儿”

回忆不计分。

词语流畅性：“请您尽可能快、尽可能多的说出您所知道水果的名称。时间是 1 分钟，准备好了吗？开始”检查者需记录受试者所说词语。

评分：≥13 个，计 2 分

8-12 个计 1 分

≤7，计 0 分

定向：“不要看手表或钟，请告诉我现在是几点钟了”“现在告诉我是哪年、哪月、星期几”“现在告诉我这是什么地方，在哪个城市？”

评分：正确回答一项给 1 分。

时间上多于 2 小时或少于 2 小时之内都正确。

受试者必须回答精确的星期和地点（医院、诊所、办公室的名称）。

计算：“想象您有很多 1 元、5 元、10 元的钱。现在您购买了 1 个 13 元的东西，需要付给我 13 元，请给我 3 种付款方式。我不会找您零钱，您需要付给我 13 元整。”当受试者提供了一个需要找零的付款方式，检查者可以鼓励受试者“还有其它方式吗”检查者记录受试者

回答正确的编号。

评分：提供 3 种付款方式， 计 3 分

提供 2 种付款方式， 计 2 分

提供 1 种付款方式， 计 1 分

未提供正确付款方式，计 0 分

抽象：请受试者回答每一类词语属于哪一类。“请您说说橘子和香蕉属于什么类别？”如果受试者回答的是某一具体特征，那么只能再提示一次：“请再换一种说法，它们还属于什么类别”，如果受试者仍未给出准确回答，则说“您说的没错，也可以说它们都是水果”。不要给出任何解释和说明。练习结束后，“现在您再说说火车和轮船属于什么类别？”如果受试者仍未给出准确回答，那么只能再提示一次“请再换一种说法，它们还属于什么类别”。当受试者再回答完毕后，“您再说说锣鼓和笛子属于什么类别？”“您再说说南方和北方属于什么类别？”

评分：回答正确，每组 1 分。

只要下列回答均视为正确。

火车和轮船：交通工具，旅行用的，运输工具，客运工具

锣鼓和笛子：乐器，娱乐工具

北方和南方：方向、地点、地方、地理位置

下列回答不正确

火车和轮船：它们都是钢铁做的，它们都有发动机，它们都耗汽油。

锣鼓和笛子：它们都是木头和其它材料做的，它们都可以发声音。

北方和南方：地理。

延迟回忆：“刚才我念了几个词让您记住，请您再尽量回忆说出这些词，如果您不记得所有词语和它们的顺序，也不需要紧张”。

评分：未经提示自由回忆正确的词，计 1 分。线索提示不计分。

先进行线索分类提示：一种花、一种蔬菜、一种家具、一种颜色、一种厨房用具

后进行线索多选提示：“桃花、菊花、梅花”

“南瓜、洋葱、萝卜”

“桌子、沙发、椅子”

“蓝色、绿色、红色”

“刀子、勺子、筷子”

视知觉：“请您看这张图片，图片里有很多重叠在一起的物品。请尽可能把它们找出来。如果您不知道它们的名字，可以指出它们的轮廓并告诉我它们的功能。不能旋转图片，您可以慢慢做。但时间不超过 1 分钟，准备好了吗？开始”指导语结束 60s 后结束测试，不能告诉受试者共有 10 件物品。

评分：受试者找出 9-10 个， 计 3 分

受试者找出 6-8 个， 计 2 分

受试者找出 4-5 个， 计 1 分

受试者找出 3 个或 3 个一下， 计 0 分

命名：“自左向右，自上向下请您告诉我这个动物的名字”

评分：每答对 1 个计 1 分，正确回答是：斑马（马或驴不得分）；孔雀（鸟不得分）；老虎

（猎豹、美洲豹和黑虎不得分）；蝴蝶（昆虫不得分）。

注意：请看这些白色背景的数字。现在请您大声读出圆形中的数字，正方形和三角形中的数字不要读。从这里开始（指向圆形 1）到这里结束（指向圆形 5）

评分：完全正确或只有一次错误，计 1 分。

2 个或 2 个以上错误，计 0 分。错误是指非圆形中数字、跳过圆形中数字、朗读数字顺序错误或读之前数字，记录错误个数。

“请看这些黑色背景的数字，现在请您大声读出圆形和正方形中的数字，三角形中的数字不要读。从这里开始到这里结束”

评分：2 个或 2 个以下错误，计 2 分

3 个错误，计 1 分

4 个或 4 个以上错误，计 0 分

右下角记录结束时间。

附：除非特殊要求，每个项目的测试指导语只能重复一遍。

MoCA-B 的分析指标为总分，不能将单个项目分视为相应认知域的表现。

节点（异常值是指小于等于节点）：文盲、小学，19 分，中学，22 分，大学，24 分。